

נוהל מס': 019.14
שם הנוהל: לידה מכשירנית
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית
לבריאות האדם

תפוצה	תחום הנוהל: נשים ומיילדות		תאריך פרסום: דצמבר 2014 מהדורה: 1 תאריך עדכון:
	שם הנוהל: לידה מכשירנית		
	כותב הנוהל: ד"ר רגדה זידאן, ד"ר רוני אברהמי		נספחים:
	האחראי על ביצוע הנוהל: פרופ' וינר זאב	מאשר הנוהל: פרופ' זאב וינר	
	על החתום:	על החתום:	
מס' דפים: 6			

תוכן העניינים

העמוד

הנושא

- | | |
|---|-----------------------|
| 2 | 1. רקע |
| 2 | 2. מטרות הנוהל |
| 2 | 3. הגדרות ומונחים |
| 3 | 4. סמכות ואחריות |
| 3 | 5. עקרונות הנוהל |
| 5 | 6. דיווח ותיעוד |
| 6 | 7. סימוכין (אסמכתאות) |

נוהל מס': 019.14
שם הנוהל: לידה מכשירנית
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רקע:

- ישנה ירידה בשכיחות ניתוחים קיסריים ומאידך עלייה בשיעור לידה מכשירנית (1).
- לפי הדו"ח של החברה הישראלית לרפואת האם והעובר לשנת 2013, שיעור לידה מכשירנית הינו 2.5% (+/-) 7.2%, ושיעור לידת מלקחיים הינו 2.5%.
- השכיחות של לידה מכשירנית בארה"ב היום עומדת על 10-15%.
- יילוד מכשירני, מתייחס ליילוד ע"י שולפן ריק או מלקחיים. הבחירה של המכשיר, תעשה בהתאם לניסיונו של המבצע והנסיבות הרפואיות. יש לזכור שלכל אחד מהמכשירים יש יתרונות וחסרונות שאותם יש לקחת בחשבון בעת בחירת המכשיר המתאים (2).
- לציין - מכיוון שהשיטה המועדפת במחלקתנו, הינה לידת וואקום, הפרוטוקול מתייחס ליילוד מכשירני ע"י וואקום.
- בשנים האחרונות ישנה עליה במודעות לגבי התחלואה העוברית והאימהית הקשורה ליילוד מכשירני. אולם, יש לזכור שגם ניתוח קיסרי בשלב השני של הלידה, כרוך בתחלואה משמעותית לאם ולילוד והשלכות משמעותיות לגבי ההריונות והלידות הבאים.
- לכן יש צורך לשמר את האפשרות לבצע יילוד מכשירני תוך כדי שמירה של כללי הבטיחות וקיום תנאים מתאימים אשר יאפשרו לידה מכשירנית בטוחה לאם ולילוד (2).

מטרות הנוהל:

להגדיר לידה מכשירנית, התוויות ו- התוויות נגד ליילוד לידני מכשירני, תנאים ו-אופן הביצוע, ומי מורשה לבצע לידה מכשירנית.

הגדרות:

החלוקה של משורי האגן בלידה מכשירנית לפי ACOG - החלק המקדים הוא חלקו הגרמי של הראש, גובה החלק המקדים יימדד בס"מ (5- עד 5+), מעל ומתחת הספינות (Ischial spines) (2).

לפי הגדרות משורי האגן בלידה מכשירנית ע"פ ACOG, ככל שהחלק המקדים של הראש נמוך יותר ופחות בסיבוב, כך הסיכוי לפגיעה אימהית או עוברית פוחת (1). מאידך ככל שהראש גבוה באגן, עולים הסיכויים העובריים ואימהיים (3).

נוהל מס': 019.14
שם הנוהל: לידה מכשירנית
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



1. מוצא האגן OUTLET:
 - הקרקפת נראית בפתח הנרתיק בלי פישוק השפתיים. כאשר החלק הגרמי של הראש הגיע למוצא האגן והוא לוחץ על החיץ.
2. נמוך באגן LOW:
 - החלק הגרמי המקדים של הראש מצוי בגובה +2 ס"מ או נמוך יותר באגן אך לא מגיע עד מוצא האגן.
3. אמצע האגן MID:
 - החלק הגרמי המקדים של הראש מצוי בגובה +2-0 ס"מ
4. גבוה באגן HIGH:
 - החלק הגרמי המקדים של הראש מצוי בגובה מעל הספינות.

סמכות ואחריות:

1. ילוד לידני מכשירני, יכול להתבצע ע"י מיילד מומחה או שאינו מומחה, שהוסמך ע"י מנהל המחלקה או בהשגחתו של מיילד מומחה.
2. במקרה חירום, שבו חיי העובר או היולדת בסכנה, רשאי כל רופא לבצע כל פעולה מן המתוארות למעלה (2).
3. מכיוון שהשיטה המועדפת במחלקתנו, הינה לידת וואקום, הפרוטוקול מתייחס לילוד מכשירני ע"י וואקום.
4. לידת מלקחיים תעשה רק ע"י רופאים שקיבלו הרשאה ע"י מנהל המחלקה.

עקרונות הנוהל:

הוריות להתערבות מכשירנית במצג ראש:

- אין התוויות מוחלטות ללידה מכשירנית, אך ההתוויות הבאות אפשריות במצבים הבאים (1):
1. שלב שני מוארך.
 2. חשד לקיפוח עוברי מיידי, או פוטנציאל למצוקה עוברית
 3. קיצור שלב שני לטובת היולדת:
 - a. תשישות היולדת
 - b. חוסר יכולת של היולדת ללחוץ
 - c. מחלה אימהית (או כל מצב רפואי שאושר ע"י מומחה בתחום ומקובל על הרופא המיילד).

תנאים להתערבות (3,4):

תנאים מיילדותיים:

1. פתיחה גמורה של הצוואר (פרט למקרים מיוחדים)
2. קרומים פקועים
3. מצג ראש (VERTEX).
4. חלקו הגרמי המקדים של הראש בגובה נמוך (LOW) או ביציאה (OUTLET). בתחנת אמצע האגן (MIDPELVIS) דרוש שיקול דעת ומיומנות מיוחדת בשל שיעור גבוה יותר של סיבוכים (2).

נוהל מס': 019.14
שם הנוהל: לידה מכשירנית
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



הכנת האישה:

1. יש צורך להסביר לאישה לגבי הפעולה.
2. יש לרוקן את שלפוחית השתן.
3. אפיזיוטמיה ואלחוש רצויים, אך אינם הכרחיים (2). אם אכן מבוצעת, מומלצת אפיזיוטמיה מדיולטרלית עם זווית גדולה.
4. להחליף ניטור פנימי במידה וקיים בעיה ברישום הניטור החיצוני.

תנאים הקשורים לצוות הרפואי:

5. ניתן לבצע יילוד מכשירני בחדר לידה או בחדר ניתוח (2).
6. נוכחות רופא ילדים
7. הצוות צריך להיות ערוך לבצע ניתוח קיסרי, במקרה של כשלון לידה מכשירנית, ללא עיכובים.

התוויות נגד לידה מכשירנית:

- במצבים מסוימים יש להימנע מלידה מכשירנית (רמת הוכחה IV) (2):
1. מצג פנים
 2. אם העובר אמור להיוולד עם נטייה לשברים (כמו osteogenesis imperfecta).
 3. בעיות קרישה בעובר (כמו Alloimmune thrombocytopenia, Hemophilia, Von Willebrand's disease).
 4. שימוש בואקום לפני שבוע 34 (הורית נגד יחסית).

אופן ביצוע לידת ואקום:

1. מיקום הואקום - ישנה חשיבות למיקום נכון של כיפת הואקום. יש להניח את הואקום על הנקודה הנקראת Flexion point / Pivot point (מרחק 2 ס"מ קדמית לפונטנלה האחורית).
2. הלחץ המומלץ נע בין 550-600 mmHg (3).
3. לפני העלאת הלחץ יש לוודא שאין רקמה נרתיקית מתחת לכיפת הואקום (3).
4. המשיכה הינה בציר האגן, מתחילה עם תחילת הציר ובמקביל עם הלחיצות של האישה (3).
5. משיכות בין הצירים אינן מומלצות, מכיוון שזה דורש כוח גדול יותר ע"מ להוריד את הראש, ומעלה הסיכוי להתנתקות כיפת הואקום (2,3).
6. תנועות כמו סיבוב ו- נדנוד/נענוע, אינם מומלצים (3).
7. אין מספיק מידע (evidence based) לגבי משך זמן מקסימלי, ומספר מקסימלי של משיכות ושל התנתקות כיפת הואקום, אך ישנה הסכמה כללית ש:
 - 7(א). אם אין התקדמות לאחר 3 משיכות, מומלץ להפסיק את הפעולה (2,3).
 - 7(ב). מומלץ להפסיק את לידת הואקום במידה והגביע נשמט שלוש פעמים, במקרה של כשל טכני רשאי מומחה לבצע ניסיון נוסף (2).
 - 7(ג). מומלץ משך זמן שלא יעלה מעל 30 דקות מתחילת המשיכות (2).
- Cephalohematoma שכיחה יותר, ככל שזמן הפעולה מתארך (1).
8. בסוף הפעולה יש לבדוק היטב את היילוד והיולדת ע"מ לשלול טראומה מהלידה.

נוהל מס': 019.14
שם הנוהל: לידה מכשירנית
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



תיעוד ודיווח:

יש לכתוב דו"ח לפי טופס דווח מחלקתי (בין השאר יש לציין שיקולים לביצוע, משך הפעולה ומספר המשיכות) .

נקודות חשובות בעת ביצוע לידה מכשירנית:

1. ילוד מכשירני כרוך ביתרונות וסיכונים שונים -הסיכונים הקשורים ליילוד בשולפן ריק כוללים המטומה של הקרקפת cephalhematoma. ובמקרים נדירים דימומים ברשתית והמטומה סוב גליאלית (subgaleal hematoma) (רמת הוכחה Ia) (2).
2. לידת מלקחיים קשורה בשכיחות גבוהה יותר של קרעים בתעלת הלידה ובחבלות חיצוניות בפנים של היילוד (2).
3. במצבים מיוחדים יוכל רופא מומחה לשקול ולבצע לידת שולפן ריק, כאשר הפתיחה עדיין לא מלאה או כאשר ראש העובר גבוה מ-2+.

נוהל מס': 019.14
שם הנוהל: לידה מכשירנית
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



מקורות

1. American College of Obstetricians and Gynecologists : Operative Vaginal Delivery: ACOG PRACTICE BULLETINE no.17, June 2000. Washington DC: ACOG 2000.
2. ניירות העמדה של האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה: ילוד לידני מכשירני. נובמבר 2008.
3. OBSTETRICS, Normal and Problem Pregnancies: Operative Vaginal Delivery. Chapter 15, 2012.
4. Royal College Of Obstericians and Gynaecologists : Operative Vaginal Delivery, Guideline No. 26. January 2011.
5. .Keriakos , S.Sugumar & N.Hilal, Instrumental vaginal delivery-back to basics. : Journal of Obstetrics and Gynecology, November 2013.